MR slēdziens - kreisais plecs

SYNLAB Rovaniemi, izmeklējums 19.10.2026, slēdziens 20.10.2026. 1,5 T GE Optima MR360, bez kontrastvielas.

Oriģināls (angļu valodas versija)

MRI of the left shoulder: The rotator cuff structures appear normal in terms of signal and morphology; there is no tear. No effusion is observed in the subdeltoid bursa. In the glenohumeral joint, the posterior labrum exhibits increased signal intensity—consistent with a contusion—along its entire extent, surrounded by a thin zone of edema. No avulsion-type tear of the labrum is identified. In the humerus, an area of increased bone signal (measuring approximately 1.5 x 1.0 cm) is present anteriorly, beneath the articular surface; this is consistent with a bone contusion. The findings are suggestive of a posterior dislocation/subluxation event (posterior), involving a contusion of the labrum and bone contusion changes in the humeral head. In the lower third of the anterior labrum, a thin, continuous strand is visible along the inner margin; this is likely a normal anatomical variant. There is no tear. The biceps tendon appears normal. No muscle tears are observed. The AC joint is normal. -The findings in the glenohumeral joint are consistent with a post-dislocation/subluxation event (posterior): there is a contusion-type change in the posterior labrum with surrounding edema, as well as a bone contusion in the anterior aspect of the humeral head.

Tulkojums latviski

TULKOJUMS no angļu valodas latviešu valodā

Kreisā pleca magnētiskās rezonanses izmeklējuma slēdziens

SYNLAB Rovaniemi, izmeklējums 19.10.2026., slēdziens 20.10.2026. - 1 lapa

IZMEKLĒJUMS

RADIOLOGA APRAKSTS

Kreisā pleca MR: rotatoru manšetes struktūras ir normālas gan pēc signāla, gan pēc morfoloģijas; plīsuma nav. Subdeltoidālajā bursā šķidruma uzkrājums nav novērojams.

Glenohumerālajā (pleca) locītavā mugurējā labrum (locītavas lūpa) visā tās garumā uzrāda paaugstinātu signāla intensitāti, kas atbilst sasitumam (kontūzijai), ap to ir plāna tūskas zona. Labrum atrāvuma tipa plīsums nav konstatēts.

Augšdelma kaulā (humerus) priekšpusē, zem locītavas virsmas, ir paaugstināta kaula signāla zona aptuveni 1,5 x 1,0 cm; tas atbilst kaula sasitumam (kaula kontūzijai).

Atrade liecina par mugurējas (posterioras) izmežģījuma/subluksācijas epizodi ar locītavas lūpas sasitumu un kaula sasituma izmaiņām augšdelma kaula galviņā.

Priekšējās labrum apakšējā trešdaļā gar iekšējo malu redzama plāna, nepārtraukta josla; visticamāk, tas ir normāls anatomisks variants. Plīsuma nav. Bicepsa cīpsla ir normāla. Muskuļu plīsumi nav novēroti. Akromioklavikulārā (AC) locītava ir normāla.

SLĒDZIENS

Atrade glenohumerālajā locītavā atbilst stāvoklim pēc mugurējas (posterioras) izmežģījuma/subluksācijas epizodes: mugurējā locītavas lūpā ir sasituma tipa izmaiņas ar apkārtēju tūsku, kā arī kaula sasitums augšdelma kaula galviņas priekšējā daļā.

Piezīme: tulkots no radiologa slēdziena angļu valodas versijas. Medicīniskie termini: labrum = locītavas lūpa; kontūzija = sasitums; subluksācija = daļējs izmežģījums; rotatoru manšete = plecu stabilizējošo cīpslu grupa.